이상지질혈증, 수치를 알면 혈관이 보입니다

고지혈증(이상지질혈증) — 진단 기준, 위험도별 치료 목표, 약과 생활 관리

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

고지혈증은 혈관 안에서 조용히 진행합니다

나쁜 콜레스테롤(LDL)이 혈관벽에 쌓여 수년에 걸쳐 혈관을 좁힙니다

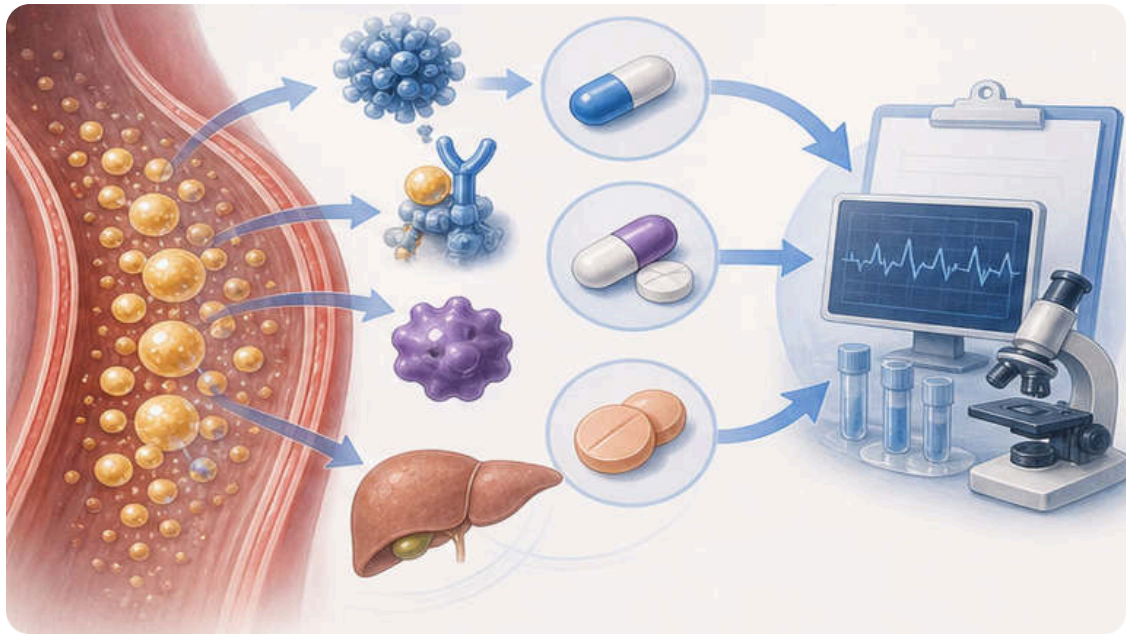


그림 · 혈관벽에 쌓인 콜레스테롤(노란 알갱이)을 약과 정기 검사로 관리하는 흐름입니다 (설명용 그림).

치료의 첫 번째 목표 — LDL

LDL 콜레스테롤은 동맥경화의 핵심 원인이자 모든 진료지침의 1차 치료 목표입니다. **낮출수록 심혈관 사건이 줄어듭니다.**

혈관이 두꺼워지고 좁아집니다

매끈하던 혈관벽에 LDL이 쌓이면 벽이 두꺼워지고 좁아져 피가 덜 흐릅니다.

증상이 없을 때 관리합니다

심장 혈관에서 생기면 협심증·심근경색, 뇌혈관에서 생기면 뇌졸중이 됩니다. 증상이 나타나기 전에 수치를 관리해야 합니다.

Tip · 고지혈증은 아프지 않습니다 — 그래서 수치로 확인하고 관리합니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

콜레스테롤이 혈관을 막기까지 — 네 단계

총콜레스테롤·LDL·중성지방이 높거나 HDL이 낮으면, 한 가지만 해당해도 이상지질혈증입니다

1

LDL이 혈관벽으로

시작

피 속에 LDL이 너무 많으면 혈관 안쪽 벽으로 스며듭니다.

2

산화되고 쌓입니다

수년

벽 안의 LDL이 변질되고, 이를 삼킨 면역세포가 지방 덩어리(거품세포)가 됩니다.

3

죽상경화반

혈관 좁아짐

지방 덩어리가 쌓여 혹(죽상경화반)이 되고 혈관이 좁아집니다.

4

심장·뇌·다리 혈관 질환

결과

협심증·심근경색·뇌졸중·말초동맥질환으로 진행할 수 있습니다.

보조 목표 — 비HDL 콜레스테롤 중성지방이 높을 때는 LDL과 함께 '총콜레스테롤에서 HDL을 뺀 값'도 봅니다.

Tip · 핵심은 '혈관에 자국이 남기 전에' 수치를 관리하는 것입니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 유럽심장학회·동맥경화학회 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국인 이상지질혈증 진단 기준

네 가지 중 하나라도 해당하면 이상지질혈증입니다 (단위 mg/dL)

항목	좋음	경계 · 높음
총콜레스테롤	200 미만	경계 200~239 · 높음 240 이상
LDL	100 미만 (100~129 정상)	경계 130~159 · 높음 160~189 · 매우 높음 190 이상
중성지방	150 미만	경계 150~199 · 높음 200~499 · **500 이상은 췌장염 위험**
HDL	60~100 (보호 인자)	**40 미만은 낮음** — 위험 인자 · 100 넘으면 보호로 치지 않음

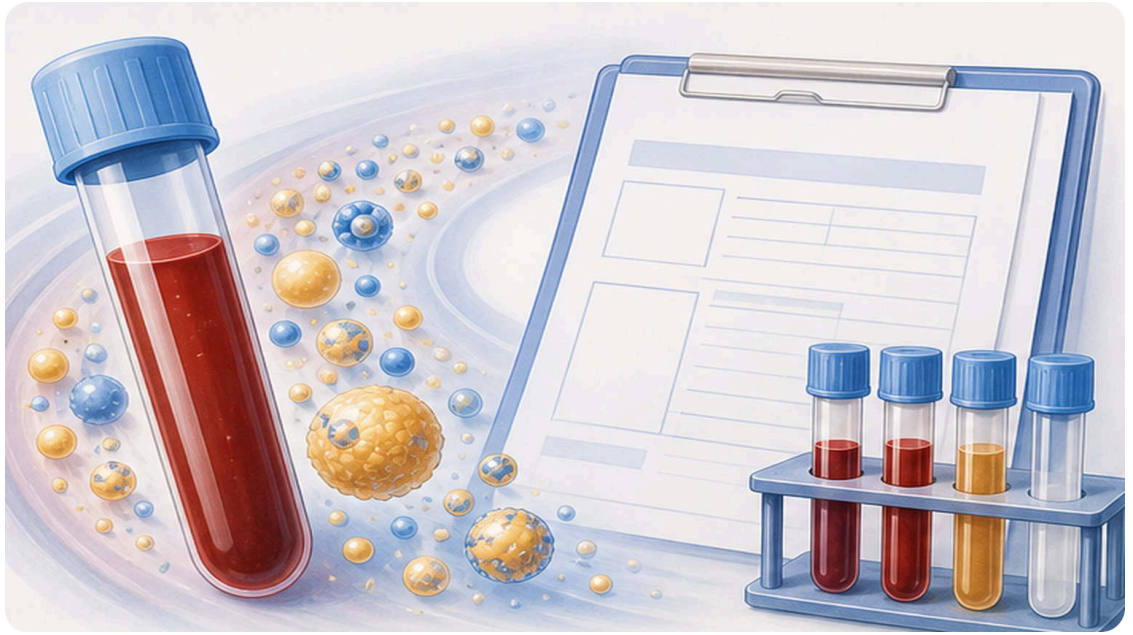


그림 · 공복 혈액검사 한 번으로 네 가지 수치를 함께 확인합니다(설명용 그림).

Tip · 총콜레스테롤만 보지 말고 LDL을 함께 봅니다 — 치료 결정의 1차 기준은 LDL입니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 진단 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

LDL 목표는 내 혈관의 위험도에 따라 다릅니다

위험이 높을수록 목표를 더 낮게 잡습니다 — '검진 정상'과 '내 치료 목표'는 다릅니다

나의 상황	LDL 목표 (mg/dL)
스텐트 · 심근경색 (관상동맥질환)	**55 미만**
뇌경색 · 일과성 허혈발작(TIA) 과거력 · 경동맥 플라크*	**70 미만**
당뇨 (10년 이상, 또는 위험인자·합병증 중 하나라도)	**70 미만**
당뇨 (10년 미만 · 위험인자·합병증 없음)	100 미만
위험인자 2개 이상	130 미만
위험인자 0~1개 (저위험)	160 미만

※ **2026 지침 선택 목표:** 재발 위험이 높은 뇌경색, 합병증이 있거나 위험인자가 3개 이상인 당뇨는 **55 미만** 까지 낮추기도 합니다.

검진 '정상' ≠ 내 목표

검진표에서 정상으로 보이는 수치도 내 치료 목표보다는 높을 수 있습니다.

* 목표를 정하는 방법

경동맥 플라크는 좁아진 정도와 전체 위험도를, 뇌경색·TIA는 원인(동맥경화 동반 여부)을 확인해 목표를 정합니다. 해당 고위험군에서는 치료 전보다 LDL을 **50% 이상** 낮추는 것도 함께 목표로 합니다.

Tip · 내 목표는 진료실에서 위험도를 확인한 뒤 함께 정합니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 광교바른내과 '내 LDL 목표' 안내문

다리동맥질환은 전신의 혈관 건강과 연결됩니다

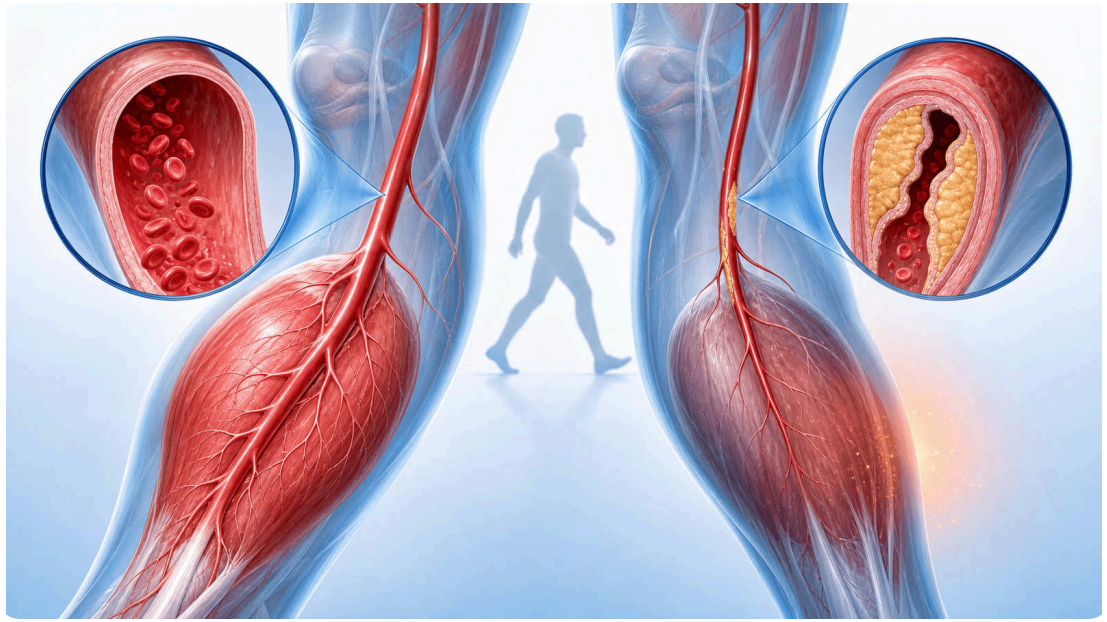
다리 증상뿐 아니라 심근경색·뇌졸중 등의 위험도 함께 줄입니다.

전신 죽상경화의 단서

말초동맥질환은 다른 혈관의 동맥경화와 함께 있을 수 있습니다. 혈압·혈당·지질 관리와 금연을 함께 합니다.

치료에서 보는 두 방향

무증상인 경우 심혈관 사건 예방을, 증상성인 경우에는 심혈관 사건과 급성 사지허혈·절단·재혈관재개통 같은 다리 사건 예방을 함께 봅니다.



다리동맥의 정상 혈관과 지질이 쌓여 좁아진 혈관을 비교한 그림입니다.

강의에서 소개한 말초동맥질환의 지질 목표

김태오 강의의 말초동맥질환 환자 관리 목표입니다.

LDL <70 mg/dL

LDL 콜레스테롤

70 mg/dL 미만으로 조절하는 목표를 소개했습니다. 비HDL 콜레스테롤은 100 mg/dL 미만을 제시했습니다.

고강도 스타틴

아토르바스타틴 40~80mg 1일 1회, 로수바스타틴 20mg 1일 1회를 예로 들었습니다.

견디기 어려울 때

낮은 강도의 스타틴과 에제티미브 병용을 설명했습니다. 복용약은 진료에서 증상과 치료 목표에 맞춰 정합니다.

노란 피부 병변도 지질 이상의 단서입니다

정준민 강의 · 황색종은 지질을 먹어 담은 조직구가 모인 피부 변화입니다.

황색종의 뜻

피부에 지질을 포식한 조직구가 모여 노란색~오렌지색의 판이나 결절로 보입니다. 위치와 형태를 함께 살핍니다.

힘줄과 관절의 결절

아킬레스건·손등 신전건의 건황색종은 LDL이 높은 2형 고지질단백혈증과 연결됩니다. 무릎·팔꿈치의 결절황색종은 3형 지질단백 이상과 연관됩니다.



건황색종과 결절황색종의 위치를 설명한 그림입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

작은 구진과 눈꺼풀 병변은 다르게 봅니다

정준민 강의 · 피부 모양만으로 콜레스테롤 수치를 판단하지 않습니다.

발진황색종

작은 노란 구진이 무리지어 생기는 모습

- 5mm 미만의 황색 구진이 모여 생길 수 있습니다.
- 중성지방이 매우 높은 경우에 나타납니다.
- 교재는 중성지방 1,000 mg/dL 초과와의 연관성을 소개했습니다.

vs

안검황색종

눈꺼풀의 편평한 황색종

- 가장 흔한 편평황색종 형태라고 설명했습니다.
- 환자의 과반수는 지질 수치가 정상일 수 있습니다.
- 가족성 고콜레스테롤혈증에서는 LDL 증가와 연결될 수 있어 혈액검사와 함께 봅니다.

위치와 모양을 진료 때 함께 보여 주세요

정준민 강의의 지질단백 이상 분류입니다.

피부 변화	위치·모양	함께 살필 단서
건황색종	아킬레스건·손등 신전건의 단단한 결절	LDL 높은 2형 고지질단백혈증
결절황색종	무릎·팔꿈치 폄쪽의 결절	3형 지질단백 이상
발진황색종	5mm 미만의 구진이 군집	중성지방 >1,000 mg/dL
안검황색종	눈꺼풀의 편평한 병변	지질 정상인 경우도 과반수, 혈액검사와 함께 해석

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

혈관 위험과 피부 단서를 함께 정리합니다

증상·검사·치료 목표를 연결해 진료에서 살펴봅니다.

다리동맥질환 확인

다리의 혈액 공급 문제와 함께 심장·뇌혈관 위험도 관리합니다.

지질 목표 정리

강의에서 제시한 말초동맥질환 목표는 LDL 70 mg/dL 미만, 비HDL 100 mg/dL 미만입니다.

피부 변화 보여 주기

황색종의 위치와 크기, 모여 생긴 양상을 진료에서 보여 줍니다.

검사와 함께 보기

눈꺼풀 병변만으로 높은 지질 수치를 단정하지 않습니다. 혈액검사와 동반질환을 함께 살핍니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

LDL 말고도 심혈관 위험을 올리는 다섯 가지

위험 인자가 몇 개인지로 위험도를 나누고, 그에 따라 LDL 목표가 정해집니다

1. **나이** — 남 45세 · 여 55세 이상
   폐경 뒤에는 여성호르몬의 보호 효과가 줄어 LDL이 빠르게 오릅니다.
2. **심장병 조기 가족력** — 부모·형제
   남자 55세 미만, 여자 65세 미만에 관상동맥질환이 생긴 가족이 있는 경우.
3. **고혈압** — 140/90 이상
   또는 혈압약 복용 중. 높은 혈압은 혈관벽 손상을 앞당깁니다.
4. **흡연** — 현재 흡연
   혈관 안쪽을 상하게 하고 LDL 변질을 부추깁니다. 금연이 가장 효과적입니다.
5. **낮은 HDL** — 40 미만
   1개로 셉니다. 반대로 HDL이 60~100이면 위험 인자에서 1개를 뺍니다(100 넘으면 보호로 치지 않음).



그림 · 혈압·흡연·가족력·비만 같은 위험 요인이 심장과 혈관에 부담을 더합니다(설명용 그림).

Tip · 당뇨·만성 콩팥병이 있으면 고위험, 이미 심장·뇌혈관 질환이 있으면 초고위험으로 봅니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 심혈관 위험도 분류

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다른 원인 때문에 수치가 오를 수도 있습니다

식사·복용 중인 약·다른 병·호르몬 변화를 먼저 확인합니다

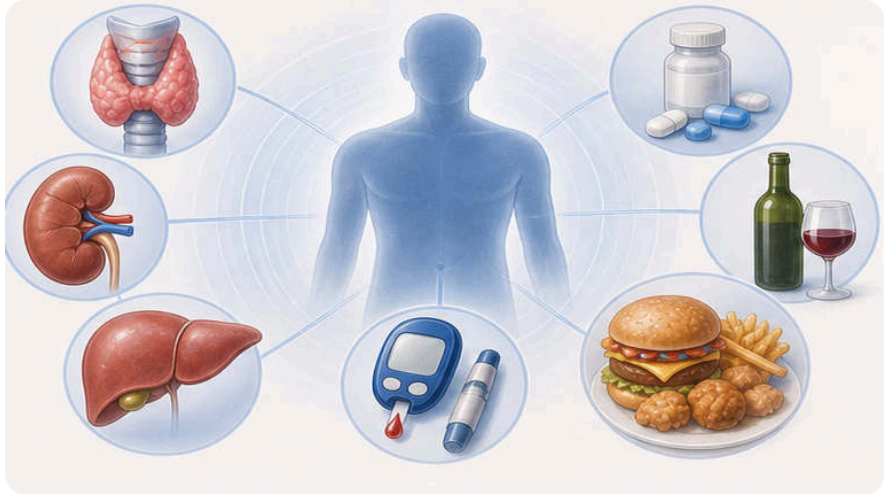


그림 · 갑상선·간·콩팥 질환, 약, 술과 식사가 수치를 올리는 다른 원인입니다(설명용 그림).

식사

포화·트랜스지방과 과식은 LDL을, 술·단 음식은 중성지방을 올립니다.

복용 중인 약

일부 이뇨제·스테로이드·부정맥약·면역억제제는 LDL을, 먹는 여성호르몬·여드름약·일부 유방암 약은 중성지방을 올립니다.

다른 병 · 호르몬

담즙이 막히는 간질환·콩팥증후군·갑상선 기능 저하는 LDL을, 만성 콩팥병·조절 안 되는 당뇨·비만·임신은 중성지방을 올립니다. 갑상선·혈당 검사를 함께 합니다.

Tip · 드시는 약을 모두 알려 주세요 — 원인을 고치면 수치가 함께 좋아지기도 합니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 이차성 원인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

스타틴 종류·용량별 강도 등급

고강도는 LDL 50% 이상, 중강도 30~49%, 저강도 30% 미만 — 용량별 감소율 표는 안내문을 드립니다

약	하루 용량 · 강도 등급
로수바스타틴	10mg 중강도 · **20·40mg 고강도**
아토르바스타틴	10·20mg 중강도 **40·80mg 고강도**
피타바스타틴	2·4mg 중강도
심바스타틴	20·40mg 중강도
로바스타틴	20mg 저강도 · 40mg 중강도
프라바스타틴	40mg 중강도(경계)

고강도 스타틴

아토르바스타틴 40·80mg, 로수바스타틴 20mg 이상 — 초고위험·고위험군에서 LDL을 크게 낮출 때 씁니다.

중등도 스타틴

아토르바스타틴 10·20mg, 로수바스타틴 5·10mg, 피타바스타틴 2·4mg — 많은 분이 이 단계에서 시작합니다.

약 선택은 함께

위험도, 현재 수치와 목표의 차이, 근육·간 부작용 여부를 보고 약과 용량을 정합니다.

Tip · 같은 약이라도 사람마다 효과가 달라, 복용을 시작한 뒤 혈액검사로 효과를 확인합니다.

근거 · 2018 미국심장학회·미국심장협회 콜레스테롤 지침 강도 등급 · 한국지질·동맥경화학회 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

목표에 못 미치면 함께 쓰는 약들

목표 미달이거나 부작용으로 용량을 올리기 어려울 때 병합하거나 새 계열을 씁니다

에제티미브

장에서 콜레스테롤 흡수를 막습니다. 혼자 약 15~20%, 스타틴과 함께 쓰면 약 18~25% 더 내려갑니다.

스타틴 + 에제티미브 복합제

두 약을 한 알로 — 챙기기 쉽고, 근육 부작용 걱정을 줄이며 더 낮출 때 씁니다.

PCSK9 억제 주사

2~4주에 한 번 피하 주사. LDL이 50~60% 더 내려갑니다. 유전성 고콜레스테롤혈증·초고위험군에서 씁니다.

벰페도산 · 인클리시란

스타틴을 못 쓰거나 더 낮춰야 할 때의 새 약입니다. 인클리시란은 6개월에 한 번 주사합니다.

피브레이트 · 오메가-3

중성지방이 매우 높을 때(500 이상, 췌장염 위험) 씁니다. 스타틴과 함께 쓰면 근육 증상을 살핍니다.

담즙산 제거제

담즙산을 몸 밖으로 내보내 LDL을 낮춥니다. 변비·배 불편감 때문에 드물게 씁니다.

Tip · 한 약을 무리하게 올리기보다 두 약을 함께 쓰는 편이 더 안전할 때가 많습니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 유럽심장학회·동맥경화학회 2019 병합요법

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

생활 습관은 약만큼 중요합니다

모든 치료의 기본입니다 — 다만 LDL은 간의 생성 능력(유전) 영향이 커서 식사만으로 목표에 못 미치면 약을 함께 씁니다

이렇게 하세요

채소·통곡물·콩·생선 위주의 지중해식 식단

- 등푸른 생선 주 2회 이상
- 중강도 유산소 운동 주 150분
- 체중 5~10% 감량 — LDL·중성지방 함께 개선
- 식이섬유 하루 25~30g (귀리·콩·과일)
- 금연 — HDL이 가장 빨리 오릅니다

vs

이것은 피하세요

포화지방·트랜스지방·단 음료 줄이기

- 마가린·튀김·과자 (트랜스지방)
- 삼겹살·갈비·버터·치즈 과량
- 단 음료·정제 탄수화물 (중성지방 상승)
- 음주 — 남 2잔, 여 1잔 초과
- 약을 마음대로 끊기 · 건강기능식품에만 의존

Tip · 약을 먹어도 식사·운동은 계속합니다 — 둘이 함께일 때 효과가 가장 큽니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 생활습관 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

고지혈증은 평생 관리하는 만성질환 — 수치를 알면 위험을 줄일 수 있습니다

01 LDL이 1차 목표 — 낮출수록 심혈관 사건이 줄어듭니다

02 위험도에 따라 LDL 목표가 다릅니다

03 스텐트·심근경색은 55 미만, 뇌경색·TIA는 70 미만

04 위험 인자 — 나이·가족력·고혈압·흡연·낮은 HDL

05 스타틴이 기본 약 — 위험도에 맞춰 강도를 고릅니다

06 목표 미달이면 에제티미브·주사제를 함께 씁니다

07 지중해식·운동·금연·체중 5~10% 감량이 약효를 키웁니다

08 약은 마음대로 끊지 말고 정기 검사로 확인합니다

Tip · 수치를 알고, 목표를 맞추고, 치료를 이어가는 것 — 이 세 가지가 전부입니다.

근거 · 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 내 목표 수치는 LDL 목표 안내문, 약 세기는 스타틴 안내문, 결과지 읽는 법은 콜레스테롤 결과지 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

고지혈증 진단을 받았거나 검진에서 콜레스테롤이 높게 나온 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 내 목표와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 유럽심장학회·동맥경화학회 이상지질혈증 지침(2019) · 광교바른내과 '내 LDL 목표' 안내문

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요